

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5012949-25.2025.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL CASSIO MURILO MONTEIRO GRANZINOLI

RECORRENTE: DANIEL FERREIRA DE OLIVEIRA

RECORRENTE: SANDRA LUCIA FERREIRA DE OLIVEIRA

RECORRIDO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

SAÚDE. DIABETES MELLITUS TIPO 1. BOMBA DE INFUSÃO DE INSULINA E SEUS INSUMOS. MEDICAMENTOS E INSUMOS PLEITEADOS NÃO ESTÃO PADRONIZADOS EM NENHUMA LISTA OFICIAL. ENUNCIADO 12 DO CNJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA INEFICÁCIA DO TRATAMENTO DO SUS. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora. Condeno a Recorrente nas verbas sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, mas suspendo em razão da gratuidade de justiça ora deferida. Publique-se. Intime-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 25 de março de 2025.

5012949-25.2025.4.02.5101

510015740992 .V5

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5012949-25.2025.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL CASSIO MURILO MONTEIRO GRANZINOLI

RECORRENTE: DANIEL FERREIRA DE OLIVEIRA

RECORRENTE: SANDRA LUCIA FERREIRA DE OLIVEIRA

RECORRIDO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RELATÓRIO

Trata-se de medida de urgência interposta pela parte autora em face da decisão, *verbis*:(*processo 5000558-38.2025.4.02.5101/RJ, evento 8, DESPADEC1*)

"DANIEL FERREIRA DE OLIVEIRA, neste ato representado por SANDRA LUCIA FERREIRA DE OLIVEIRA, propõe a presente demanda, pelo rito dos Juizados Especiais Federais, com pedido de antecipação de tutela e provimento final, por meio da qual a parte autora, portador de diabetes mellitus tipo 1 (C10: E10), requer a condenação da União Federal, do Estado/RJ e do Município do Rio de Janeiro, em responsabilidade solidária, na obrigação de fornecerem bomba de infusão de insulina e seus insumos, de acordo com a respectiva prescrição médica.

Parecer técnico acostado pelo NAT-Jus no evento 6.1.

Passo a decidir.

Inicialmente, de acordo com os documentos médicos que instruem a exordial, verifico que a parte autora apresenta "labilidade glicêmica importante", com indicação para uso de bomba de infusão de insulina Sistema MiniMed® 780G -Start Kit e seus demais insumos.

Acerca da condição do autor, o órgão técnico esclareceu o seguinte:

"No diabetes mellitus tipo I ocorre a destruição da célula beta levando a deficiência absoluta de insulina. Desta forma, a administração de insulina é necessária para prevenir cetoacidose. A destruição das células beta é geralmente causada por processo autoimune (tipo 1 autoimune ou tipo 1A), que pode ser detectado por autoanticorpos circulantes como antidescarboxilase do ácido glutâmico (anti-GAD), anti-ilhotas e anti-insulina. Em menor proporção, a causa é desconhecida (tipo 1 idiopático ou tipo 1B). A destruição das células beta em geral é rapidamente progressiva, ocorrendo principalmente em crianças e adolescentes (pico de incidência entre 10 e 14 anos), mas pode ocorrer também em adultos.

A hipoglicemia é uma afecção em que as concentrações de glicose sanguíneas são anormalmente baixas. É uma síndrome de nível anormalmente baixo de glicemia. A hipoglicemia clínica tem várias etiologias. A hipoglicemia grave eventualmente leva a privação da glucose no sistema nervoso central resultando em fome, sudorese, parestesia, comprometimento da função mental, ataques, coma e até morte.

A variabilidade glicêmica ou labilidade glicêmica caracteriza-se quando o paciente apresenta frequentemente episódios de hipoglicemia ou hiperglicemia e pode apresentar como causas o uso incorreto da insulina (NPH e Regular), alterações hormonais da puberdade, menstruação e gestação, ou ainda as associadas a alterações do comportamento alimentar, ou a complicações do próprio diabetes, como gastroparesia, neuropatia autonômica e apneia do sono, usam de medicações capazes de induzir a resistência à insulina, dentre outras causa".

Nesse contexto, informa-se que os produtos vindicados estão indicados para manejo do quadro clínico do autor, porém não são padronizados em nenhuma lista oficial de insumos para dispensação no SUS, no âmbito do Município e do Estado do Rio de Janeiro.

Todavia, apesar da indicação em tela, ressalta-se que o uso do referido equipamento não é imprescindível, veja-se:

"Isto decorre do fato, de não se configurar item essencial em seu tratamento, pois pode ser realizado através de múltiplas doses de insulinas aplicadas por via subcutânea durante o dia (esquema padronizado pelo SUS) ou sistema de infusão contínua de insulina (sistema não padronizado pelo SUS), sendo ambas eficazes no tratamento dos pacientes diabéticos". (Grifei).

Ainda sobre o tema, o órgão técnico destacou o seguinte:

"Elucida-se, ainda, que de acordo com o Protocolo Clínico e Diretrizes terapêuticas de diabetes mellitus tipo 1, o uso de bomba de infusão de insulina (BISI) foi comparado ao esquema basal-bolus com múltiplas doses de insulina em metanálises de ensaios clínicos randomizados, mostrando redução pequena e clinicamente pouco relevante da HbA1c (em torno de 0,3%). Em relação à ocorrência de hipoglicemias, as metanálises mostraram resultados variados: alguns estudos mostram redução da frequência de hipoglicemias graves, enquanto outros não mostram qualquer redução. Considerando o desfecho qualidade de vida, a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC) considerou que as evidências ainda são insuficientes para dar suporte à inclusão dessa tecnologia.

Assim, a CONITEC em sua 63ª reunião ordinária, no dia 31 de janeiro de 2018, **recomendou a não incorporação no SUS do sistema de infusão contínua de insulina (bomba de infusão de insulina) para o tratamento de pacientes com diabetes tipo 1 que falharam à terapia com múltiplas doses de insulina. Os membros do Plenário ponderaram que os estudos apresentados não fornecem evidências suficientes que comprovem benefícios clínicos da terapia e que a avaliação econômica é limitada e sem um modelo bem definido**". (Grifei).

Logo, embora indicados ao caso do autor, o aparelho e acessórios pretendidos não são essenciais ao tratamento do requerente (ainda que inegáveis a praticidade, o conforto e a qualidade de vida) que justifique o dispêndio de elevado valor direcionado a uma única pessoa em detrimento dos demais administrados, ao passo que existem métodos eficazes já padronizados pelo SUS.

Com efeito, em relação à obrigatoriedade de fornecimento gratuito de insumos, não incluídos na listagem oficial do SUS, para tratamento da enfermidade do suplicante, é relevante a análise dos possíveis reflexos da decisão favorável à parte autora nas políticas públicas, já que não podem os recursos destinados aos programas de saúde serem distribuídos fora de um critério minimamente razoável, considerando-se o conjunto da população.

Importante ressaltar que não obstante ser a saúde direito de todos e dever do estado (art. 196 da CRFB/88), ele "é assegurado mediante políticas sociais e econômicas. Ou seja, não há um direito absoluto a todo e qualquer procedimento necessário para a proteção, promoção e recuperação da saúde, independentemente da existência de uma política pública que o concretize."

In casu, a parte autora possui enfermidade para a qual o SUS já disponibiliza programa específico e eficaz, de forma que não cabe ao Poder Judiciário impor à Administração adoção de políticas de saúde diversas daquelas preconizadas pela rede pública por mera questão de conveniência: uma coisa é a imprescindibilidade do tratamento requerido, outra é a maior comodidade para o paciente em detrimento daquele adotado pelo Estado, que, frise-se, se mostra plenamente eficaz desde que o autor tome certas medidas de sua responsabilidade, tais como a prática de exercícios físicos, a alimentação adequada e a aplicação regular da insulina de forma manual.

Ante as informações apresentadas pelo NAT-Jus em seu parecer, verifico que não é possível confirmar, nessa fase da inscrição processual, a imprescindibilidade do tratamento vindicado, eis que não demonstrado o esgotamento ou a ineficácia das opções terapêuticas disponibilizadas no âmbito do SUS.

Inclusive, como apontado pelo Núcleo, o insumo pleiteado não é imprescindível para o tratamento do quadro clínico do autor e, ainda, não foi incorporado ao SUS justamente por não ter sido demonstrada a sua superioridade em relação à terapia com múltiplas doses, já disponibilizada no sistema de saúde.

Ante o exposto, **INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA**, em razão da ausência dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, conforme fundamentação supra.

Intime-se a parte autora acerca da presente decisão.

Na mesma oportunidade, citem-se os réus para o oferecimento de resposta, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 9º da Lei nº 9.099/95), devendo apresentar toda a documentação de que disponham para esclarecimento da causa, na forma do art. 11 da Lei nº 10.259/2001, bem como indicando, justificadamente, as provas que pretendem produzir, ou, havendo possibilidade de conciliação, essa deve ser clara, detalhando todos os seus termos.

Deixo de designar audiência de conciliação, instrução e julgamento, pois a não realização não importa em prejuízo para as partes.

P.I."

É o breve relatório.

VOTO

Inicialmente, quanto à legitimidade passiva e à solidariedade dos entes públicos federativos, *verbis*:

“Processo REsp 1203244 / SC RECURSO ESPECIAL 2010/0137528-8

Relator(a) Ministro HERMAN BENJAMIN (1132)

Órgão Julgador S1 - PRIMEIRA SEÇÃO

Data do Julgamento 09/04/2014

Data da Publicação/Fonte DJe 17/06/2014 RIP vol. 87 p. 283

Ementa

PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA REPETITIVA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE **MEDICAMENTOS**. AÇÃO MOVIDA CONTRA O ESTADO. CHAMAMENTO DA UNIÃO AO PROCESSO. ART. 77, III, DO CPC. DESNECESSIDADE.

Controvérsia submetida ao rito do art. 543-C do CPC 1. O chamamento ao processo da União com base no art. 77, III, do CPC, nas demandas propostas contra os demais entes federativos responsáveis para o fornecimento de **medicamentos** ou prestação de serviços de saúde, não é impositivo, mostrando-se inadequado opor obstáculo inútil à garantia fundamental do cidadão à saúde. Precedentes do STJ.

2. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal entende que "o recebimento de medicamentos pelo Estado é direito fundamental, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um dos entes federativos, desde que demonstrada sua necessidade e a impossibilidade de custeá-los com recursos próprios", e "o ente federativo deve se pautar no espírito de solidariedade para conferir efetividade ao direito garantido pela Constituição, e não criar entraves jurídicos para postergar a devida prestação jurisdicional", razão por que "o chamamento ao processo da União pelo Estado de Santa Catarina revela-se medida meramente protelatória que não traz nenhuma utilidade ao processo, além de atrasar a resolução do feito, revelando-se meio inconstitucional para evitar o acesso aos remédios necessários para o restabelecimento da saúde da recorrida" (RE

607.381 AgR, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 17.6.2011). Caso concreto 3. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido negou o chamamento ao processo da União, o que está em sintonia com o entendimento aqui fixado.

4. Recurso Especial não provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 8/2008.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da PRIMEIRA Seção do Superior Tribunal de Justiça: "A Seção, por unanimidade, negou provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator." Os Srs. Ministros Napoleão Nunes Maia Filho, Og Fernandes, Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Assusete Magalhães, Sérgio Kukina, Ari Pargendler e Arnaldo Esteves Lima votaram com o Sr. Ministro Relator. Sustentaram, oralmente, os Drs. SÉRGIO LAGUNA PEREIRA, pelo recorrente, e DANIELLE ALEIXO REIS DO VALLE SOUZA, pela União.

Notas

Julgado conforme procedimento previsto para os **Recursos Repetitivos** no âmbito do STJ. Veja os **EDcl no REsp 1203244-SC** que foram acolhidos."

Assim, os cidadãos podem postular a concessão de medicamentos, insumos e, por analogia, procedimentos médicos de todos os órgãos federados.

A parte autora comprovou ser portadora de diabetes mellitus tipo 1, apresentando labilidade glicêmica importante (Evento 1, ANEXO2, Página 12 a 14). Requereu o fornecimento de bomba de infusão de insulina Sistema MiniMed® 780G -Start Kit, cateter "Set" com 60 cm de tubo de 9mm de cânula, aplicador Sillseter "QuickSet", reservatório de 3ml "Minimed® Reservoir", pilhas Energizer® AAA, Enlite Sensor 3 + adesivos para fixação, transmissor Guardian Link3 e adaptador Blue Carelink USB.

Cumpre esclarecer, primeiramente, que a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que o CONITEC e a ANVISA classificam o sistema de infusão contínua de insulina como 'produto para saúde'; logo, não se enquadra no conceito de medicamento, inserido no inciso VI do art. 10 da Lei 9.656/1998. (REsp 2.130.518/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe 18/11/2024).

Como a demanda versa sobre aquisição de produto de interesse para saúde, a competência é da Justiça Federal.

Dispõe o Enunciado 13 do CNJ: "*Nas ações de saúde que pleiteiam o fornecimento de medicamentos, produtos ou tratamentos, recomenda-se, sempre que possível, a prévia oitiva do gestor do Sistema Único de Saúde - SUS, com vistas a, inclusive, identificar solicitação prévia do requerente, alternativas terapêuticas e competência do ente federado, quando aplicável (Saúde Pública e Suplementar). (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde - 18.03.2019)*".

O NAT juntou parecer no processo 5000558-38.2025.4.02.5101/RJ, evento 6, DOC1.

Afirmou que o uso da bomba de insulina apesar de necessário para o tratamento do Autor, não é imprescindível.

articuladas para manter esquemas de múltiplas aplicações ao dia .

Diante do exposto, informa-se que o uso de bomba de infusão de insulina Sistema MiniMed® 780G -Start Kit, cateter "Set" com 60 cm de tubo de 9mm de cânula, aplicador Sillseter "QuickSet", reservatório de 3ml "Minimed® Reservoir", pilhas Energizer® AA, Enlite Sensor 3 + adesivos para fixação, transmissor Guardian Link3 e adaptador Blue Carelink USB estão indicados ao manejo de quadro clínico do Autor - diabetes mellitus tipo1, apresentando labilidade glicêmica importante (Evento 1, ANEXO2, Página 12 a 14). Contudo, não estão padronizados em nenhuma lista oficial de insumos para dispensação no SUS, no âmbito do município e do estado do Rio de Janeiro.

Salienta-se que o uso da bomba de insulina apesar de necessário para o tratamento do Autor, não é imprescindível. Isto decorre do fato, de não se configurar item essencial em seu tratamento, pois pode ser realizado através de múltiplas doses de insulinas aplicadas por via subcutânea durante o dia (esquema padronizado pelo SUS) ou sistema de infusão contínua de insulina (sistema não padronizado pelo SUS), sendo ambas eficazes no tratamento dos pacientes diabéticos⁶.

Elucida-se, ainda, que de acordo com o Protocolo Clínico e Diretrizes terapêuticas de diabetes mellitus tipo 1, o uso de bomba de infusão de insulina (BISI) foi comparado ao esquema basal-bolus com múltiplas doses de insulina em metanálises de ensaios clínicos randomizados, mostrando redução pequena e clinicamente pouco relevante da HbA1c (em torno de 0,3%). Em relação à ocorrência de hipoglicemias, as metanálises mostraram resultados variados: alguns estudos mostram redução da frequência de hipoglicemias graves, enquanto outros não mostram qualquer redução. Considerando o desfecho qualidade de vida, a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC) considerou que as evidências ainda são insuficientes para dar suporte à inclusão dessa tecnologia⁷.

Assim, a CONITEC em sua 63ª reunião ordinária, no dia 31 de janeiro de 2018, recomendou a não incorporação no SUS do sistema de infusão contínua de insulina (bomba de infusão de insulina) para o tratamento de pacientes com diabetes tipo 1 que falharam à terapia com múltiplas doses de insulina. Os membros do Plenário ponderaram que os estudos apresentados não fornecem evidências suficientes que comprovem benefícios clínicos da terapia e que a avaliação econômica é limitada e sem um modelo bem definido⁸.

No que tange o fornecimento dos insumos no âmbito do SUS, insta mencionar que as seringas com agulha acoplada (em alternativa ao pleito bomba de infusão de insulina), estão padronizadas para distribuição gratuita através do SUS, aos pacientes portadores de diabetes mellitus dependentes de insulina, pelo Programa de Hipertensão e Diabetes – HIPERDIA. Para ter acesso, a

representante legal do Autor deverá comparecer a Unidade Básica de Saúde mais próxima de sua residência, com o receituário atualizado, a fim de obter esclarecimentos acerca da dispensação.

Elucida-se que o insumo bomba de infusão contínua de insulina e seus acessórios possuem registros ativos na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA.

Acrescenta-se que há disponível no mercado brasileiro, outros tipos de bombas de infusão de insulina e seus acessórios. Portanto, cabe dizer que Minimed™ e Energizer® correspondem a marcas Leitor de PDF Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, a qual institui normas de licitação e Contratos da Administração Pública, a licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração. Sendo assim, os processos licitatórios de compras são feitos, em regra, pela descrição do insumo, e não pela marca comercial, permitindo ampla concorrência.

Por fim, salienta-se que informação acerca de custo de insumos para saúde, não consta no escopo de atuação deste Núcleo

É o parecer.

Afirmou que os medicamentos e insumos pleiteados não estão padronizados em nenhuma lista oficial de insumos para dispensação no SUS, no âmbito do município e do estado do Rio de Janeiro.

O Enunciado 12 do CNJ determina a necessidade de demonstração da ineficácia do tratamento do SUS. Nos termos do Enunciado: "*A inefetividade do tratamento oferecido pelo Sistema Único de Saúde - SUS, no caso concreto, deve ser demonstrada por relatório médico que a indique e descreva as normas éticas, sanitárias, farmacológicas (princípio ativo segundo a Denominação Comum Brasileira) e que estabeleça o diagnóstico da doença (Classificação Internacional de Doenças), indicando o tratamento eficaz, periodicidade, medicamentos, doses e fazendo referência ainda sobre a situação do registro ou uso autorizado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa, fundamentando a necessidade do tratamento com base em medicina de evidências (STJ - Recurso Especial Resp. nº 1.657.156, Relatoria do Ministro Benedito Gonçalves - 1ª Seção Cível - julgamento repetitivo dia 25.04.2018 - Tema 106). (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde - 18.03.2019)*".

Entende-se que a parte autora não comprovou a ineficácia do tratamento oferecido pelo SUS, nesse aspecto.

O NAT é composto por uma equipe de especialistas em saúde pública e para a emissão do parecer foram utilizados e analisados os documentos juntados pela parte autora.

Por fim, considero expressamente prequestionados todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais, aos quais inexistente violação.

Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora. Condeno a Recorrente nas verbas sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, mas suspendo em razão da gratuidade de justiça ora deferida. Publique-se. Intime-se.